

L'examen mental



DR BOUOUDEN
MODULE DE PSYCHOLOGIE MÉDICALE
UNIVERSITÉ₃ DE CONSTANTINE



- **1-Identité :**
- *Nom *Prénom * Age * Fratrie *Originaire de * demeurant à*Etat civil *Niveau socio-économique* Profession *Niveau de scolarité .
- **2-Motif d'hospitalisation**
- **3-ATCD :**
 - a-Personnels :**
 - Médicaux
 - Chirurgicaux
 - Psychiatriques : hospitalisations antérieures et suivi
 - Habitudes toxiques : quantité et durée
 - Gynéco-obstétricaux : si femme
 - Juridiques
 - b- Familiaux :**



- 4-Biographie (Recueillie auprès de ...)
 - a- Grossesse et naissance :
 - b-Développement psychomoteur :
 - c-Vie scolaire
 - d- Puberté et scolarité : Age de la puberté · ami(e)·
 - e-Vie professionnelle
 - f- Personnalité du malade et entourage socio-économique:
 - . Relations avec les parents et les frères .
 - . Nombre d'amis .
 - . Capacité de maintenir des relations stables.
 - . Intelligence .
 - . Hygiène corporelle et vestimentaire.
 - . Faculté d'adaptation aux changements de lieux (voyages) .
 - . Réaction aux contraintes .



-
- 5- Histoire de la maladie :
- .Début
- . Facteurs déclenchant
- . Chronologie
- .Evolution de l'état actuel.

6-Examen psychiatrique :



1- Présentation:



- **1-Tenue** : inadaptée :
 - *Excentrique (hystérique) ;
 - *Négligé sales (confusion, démence).
 - *Clownesque, choquante (accès maniaque).
 - *bizarre : schizophrénie.
- **3-mimique** : traduit le langage non verbal exprimé par la face.
 - *Hypermimie : euphorie .
 - *Hypomimie ou amimie : douleurs morale et ralentissement psychomoteur.
 - *Dysmimie : c'est la survenue d'une mimique n'ayant aucun rapport avec le discours ou l'affect exprimé .
- **4-comportement** : *Agitation ; stupeur ; Catalepsie ; Para kinésies

2-contact:



- C'est l'analyse de la relation entre le médecin et le patient.
- ***Syntone, hyper syntone** : contact facile, voir familial .
- ***Réticence** : c'est le refus volontaire de parler librement de ce que lui préoccupe principalement.
- ***Absence** : le sujet n'est pas attentif à l'entretien .

3-conduites instinctuelles:



1 -Alimentation :

- ***Anorexie, refus alimentaire :**
- . L'anorexie: se définit par la diminution ou la perte de l'appétit, qui peut être volontaire ou non.
- ***Excès alimentaires :**
- ***Conduites alimentaires aberrantes :** +pica

2-Sommeil :

- ***Insomnie :**
- +initiale, matinale, totale,
- + L'inversion du rythme circadien
- ***hypersomnie**

3-Conduites sexuelles :

- +Déviations sexuelles : -homosexualité, pédophilie
- +anomalies des fonctions sexuelles frigidité ,impuissance .

- **4-Conduites sphinctériennes :** les pertes sphinctériennes : sont rares dans les troubles psychiatriques.

4-conduites sociales:



- 1-le suicide.
- 2- Fugues : est l'abandon du domicile ou du lieu de travail sans but précis.
- 3- vols pathologiques : exemple: kleptomanie : impossibilité de résister à l'impulsion de voler des objets qui ne sont dérober ni pour un usage personnel ni pour leur valeur commerciale.
- 4-Pyromanie : allumage délibéré et réfléchi d'incendies survenant à plusieurs reprises.
- 5-homicide : rares .
- 6 -les attentats aux mœurs : (viol, inceste....) .

5-Conduites addictives



Ensemble de comportements visant au recours répété à une drogue ou à un comportement hédonique au détriment d'autres activités.

- -alcoolisme
- -toxicomanie.
- -addiction à l'internet.

6-Fonctions supérieures:



- 1-Langage : Tachyphémie : la logorrhées ,
Bradyphémie, rupture brutale (barrage idéique) ou
progressive (fading mental) du
discours , Mutisme , Stéréotypie verbale, néologisme ,
Aphasies
- 2-Fonctions mnésiques : **Amnésie** :
- .Amnésie de fixation (amnésie antérograde)
- .Amnésie d'évocation (amnésie rétrograde)
- **Hypermnésies**

6-fonctions supérieures:



- 3-fonctionnement de la pensée et du jugement :
- Troubles du cours de la pensée:
 - +Tachypsychie :
 - +Bradypsychie
- **b-Trouble du contenu de la pensée :** +idée fixe +idée obsédante +idée délirante +idée dépressive
- **C-distorsion globale de la pensée :**
 - +autistique +magique +paralogique +Rationalisme morbide
- **d- Evaluation globale de l'intelligence : +trouble du jugement par carence intellectuelle :**

6-fonctions supérieures:



- **4-Activités perceptives:**
- **a-hallucinations** :+hallucination psycho-sensorielle ,hallucination psychique .
- b-Syndrome d'automatisme mental

e-Conscience de soi et de l'environnement :



***Trouble de la vigilance** : les états compris entre une vigilance normale et coma :

-Obnubilation -Hébétude-Confusion-Coma.

***Troubles de l'attention** :

***Troubles de la conscience de soi** :

+**Trouble du schéma corporel** : membre fantôme : c'est une sensation de persistance du membre après son ablation ou son amputation.

+**Dépersonnalisation** : être détaché de soi.

+ **Déréalisation** : sentiment d'irréalité et d'étrangeté du monde extérieur

f-Etats émotionnels:



- *trouble de l'humeur :
 - +dépressive
 - +expansive
 - +athymique : absence de toute affect.
- *troubles anxieux

Examen physique



- β Constantes hémodynamiques
- β Cardiovasculaire
- β Pulmonaire
- β Neurologique
- Et autres appareils selon les signes d'appel.

Les examens complémentaires :



- En fonction de l'orientation cliniques et des signes d'appels on demande des examens complémentaires radiologiques, biologiques et psychologiques correspondants. Cependant, certains examens sont considérés comme systématiques:
- - la glycémie,
- -ionogramme sanguin.
- -bilan rénal: urée, créatinine sanguine.
- -Bilan hépatique
- -bilan thyroïdien.
- -FNS,
- - ECG, EEG,
- -test de grossesse,
- -les tests psychologiques notamment test de personnalité et les tests d'efficiency intellectuelle.



- **Regroupement syndromique**
- **Discussion diagnostique**
- **Conduite à tenir**
- **Évolution** : sur le plan comportemental , cognitif, affectif , instinctuel et physique.
- **Surveillance** : constantes++(pouls ,FR, température); ECG ; état de conscience ; transit et miction , alimentation et sommeil , imprégnation neuroleptique.
- **Pronostic dépend de :**
- La réponse au traitement , de la conscience de la maladie , de l'adhérence thérapeutique et du bon support socio familial.